IMPLANTE URETERO-VESICAL

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Lidia García González, María del Prado Sánchez Figueira, Lorenzo Giunco.

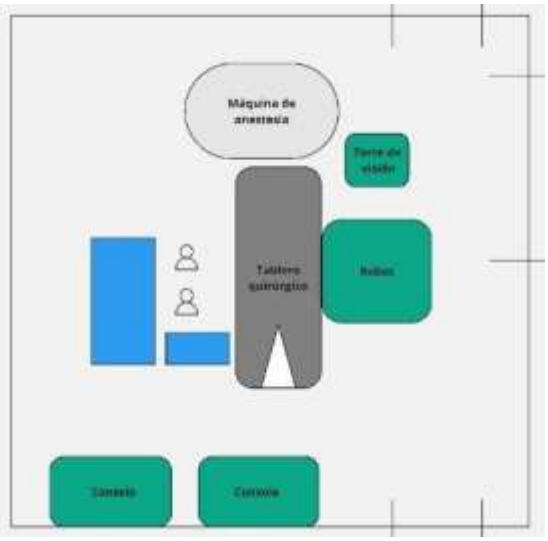
DEFINICIÓN Y OBJETIVO

El implante uretero-vesical se realiza por estenosis o por presencia de litiasis. Se recorta en uréter distal y se anastomosa en la vejiga (no es preciso tunelizar).

POSICIÓN QUIRÚRGICA PACIENTE

- Pink pad antideslizante.
- Supino con brazos alineados.
- Perneras bajas. No se quitan las perneras rectas del tablero.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

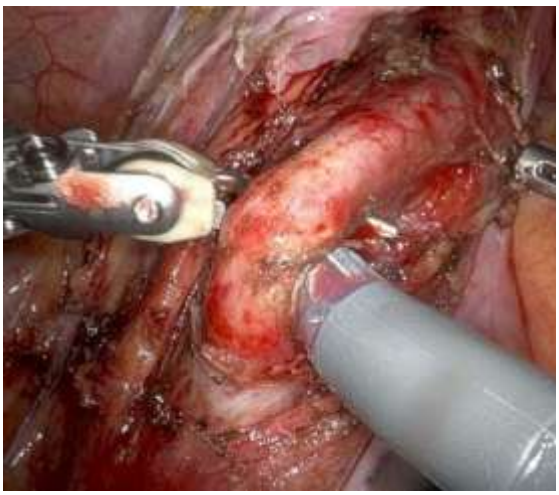
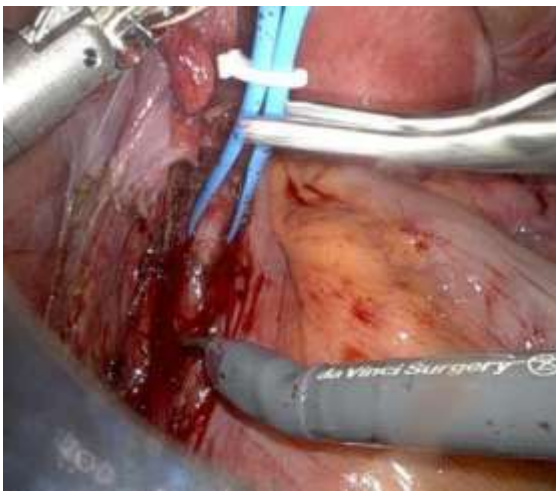


- Anatomía: pélvica
- Lado: izquierdo
  - Brazo 1: Prograsp
  - Brazo 2: Bipolar Maryland
  - Brazo 3: Endoscopio 30°
  - Brazo 4: tijeras
- Tablero quirúrgico: Trendelemburg 30- 35°
- Bajar perneras para evitar contaminación y permitir acceso cómodo al SV

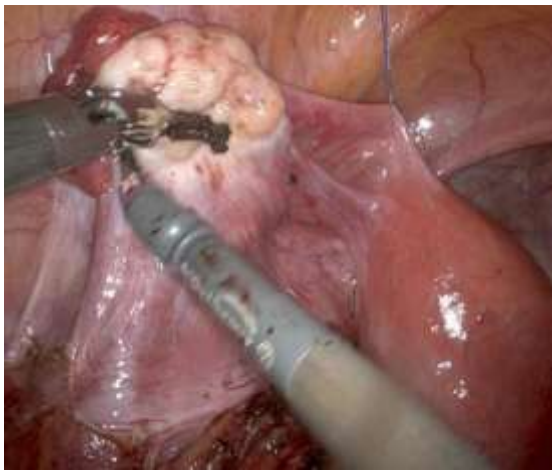
TÉCNICA QUIRÚRGICA

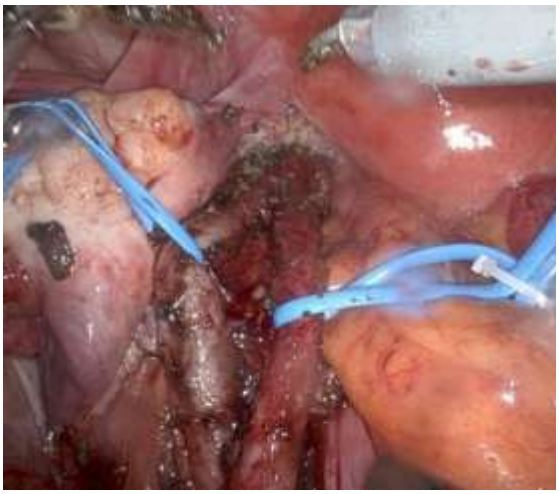
- Colocación de campo quirúrgico.
- Sondaje vesical con sonda de látex 18ch de dos luces y vaciado de la vejiga.
- Colocación de trócares.

- Se busca el uréter. En este caso clínico el uréter es doble. Puede estar adherido por la inflamación. Se referencia con vessel-loop.

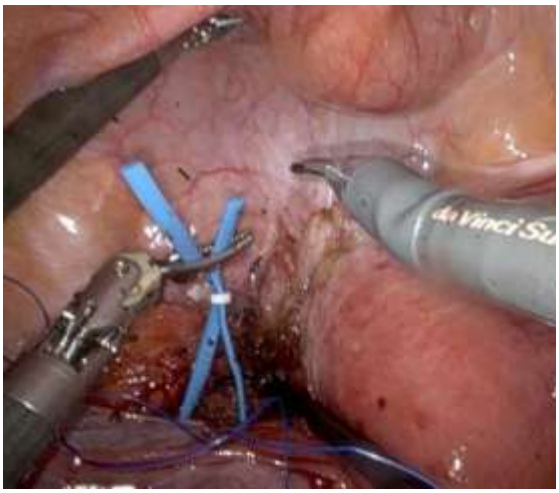
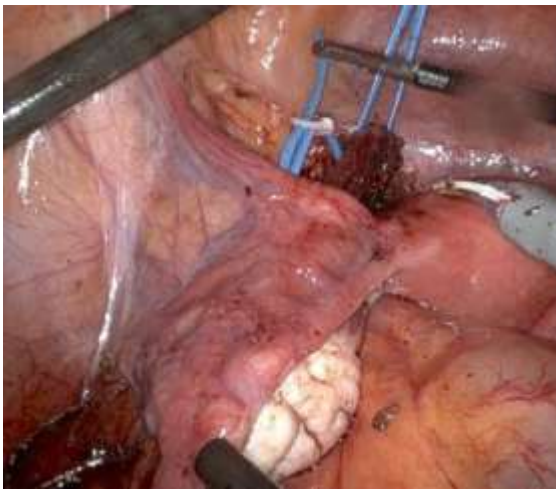



- Se puede suspender la trompa y el ovario con sutura de monofilamento tipo dafilon de 2-0 si procede.
- En el caso que se describe hay dos uréteres que se convierten en uno al llegar a la vejiga.

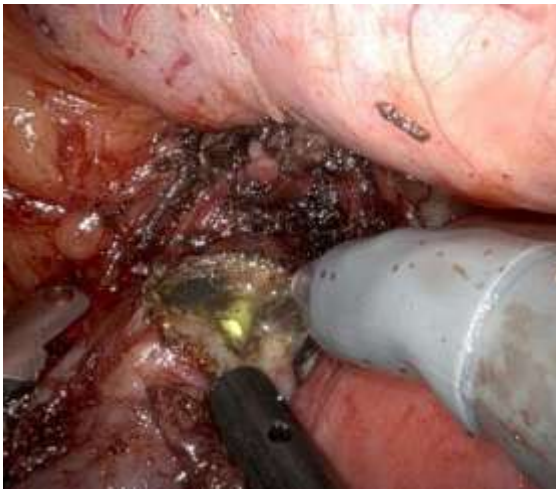
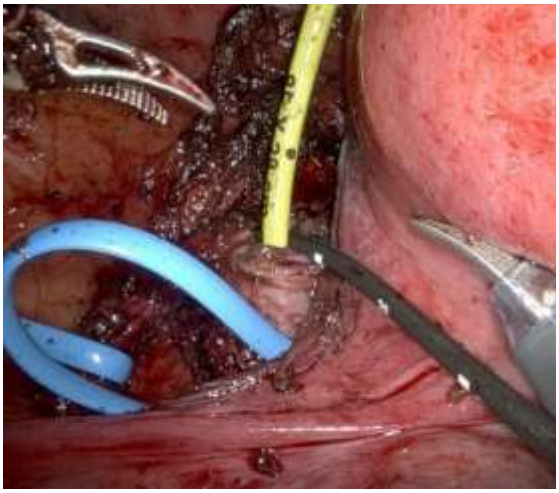


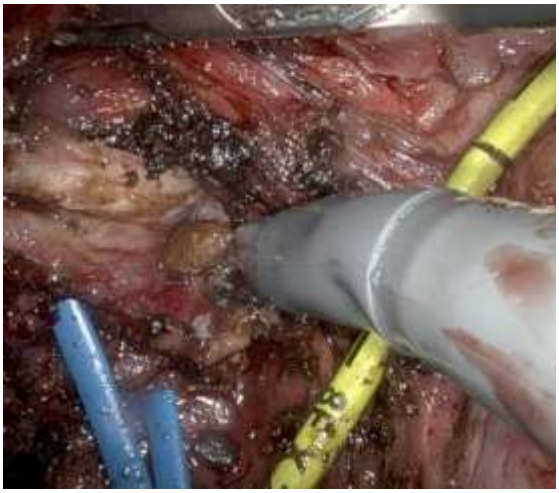
- Se hace un orificio a través del parametrio para pasar los uréteres para anastomosis. Así se evita pasarlo por delante del útero.

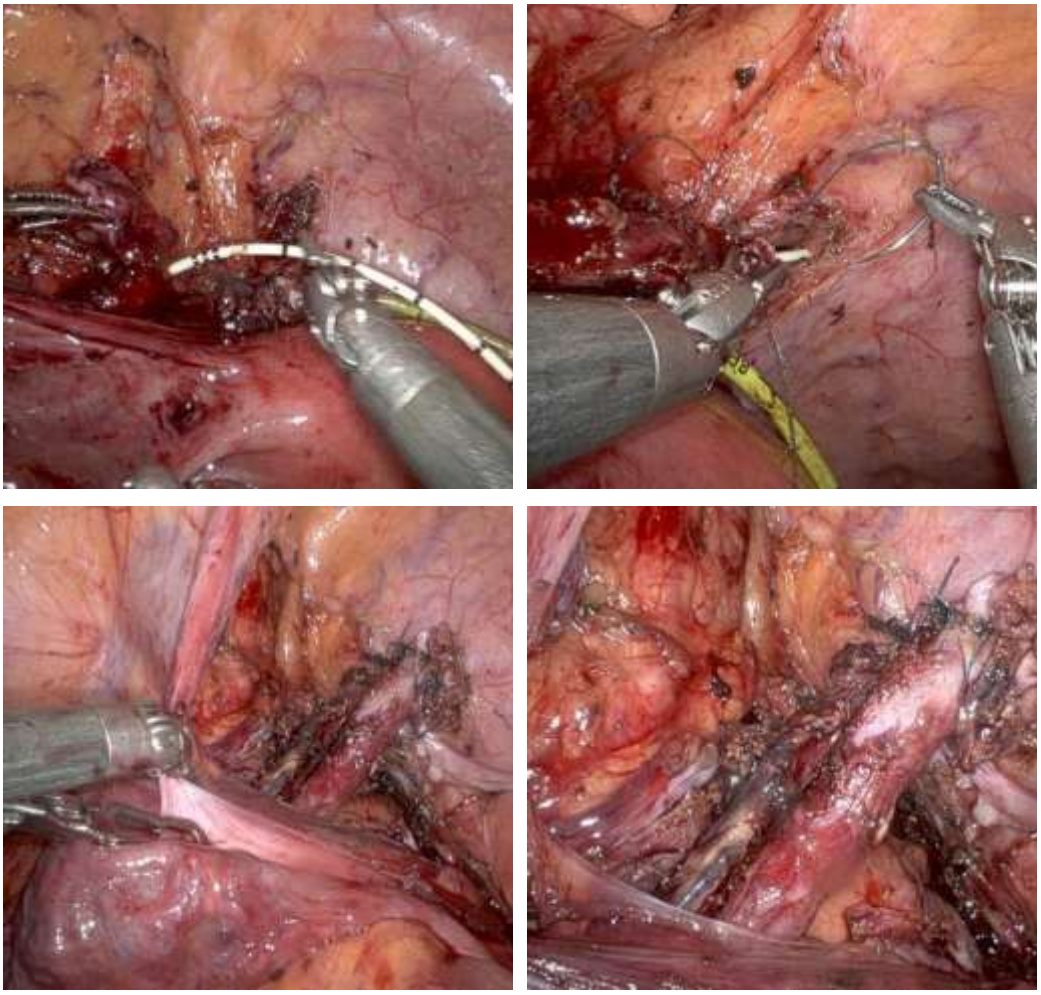
- Se visualiza el catéter al abrir el uréter (dos, en este caso).

- Al abrir el uréter aparece la piedra y se retira. Se vuelve a cerrar el orificio con sutura tipo V-loc de 3-0 cortada a unos 8 cm.

- Se preparan los uréteres y la vejiga para la anastomosis. Para facilitar la maniobra, se llena la vejiga con unos 250 cc de suero fisiológico para distenderla.
- Se retiran los catéteres doble J previos y se ponen los nuevos. Pueden ser de 4.8 ch y 28 cm. Se fijan con sutura tipo V-loc de 4-0 anudados dobles a unos 8 cm, y se refuerza la anastomosis con V-loc de 3-0.



- Se comprueba de hemostasia. Se coloca un drenaje tipo blake 19ch y se cierran las heridas.

BIBLIOGRAFIA

1. Mantica, Guglielmo, et al. El uso de la cirugía robótica para el tratamiento de estenosis uretrales y contracturas del cuello vesical: una revisión sistemática. *Actas Urológicas Españolas*, 2025, vol. 49, no 1, p. 11-19.
2. Corona-Montes, Víctor Enrique; García-Nares, S. I. I.; Zapata-González, Antonio. Reimplante ureteral asistido por robot: técnica quirúrgica y revisión. *Revista mexicana de urología*, 2017, vol. 77, no 2, p. 158-165.